



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سحر نبيل حسين الاعصر
المحافظة : الاسكندرية الحي / المدينة : الرمل
رقم البطاقة : 27712060102289 رقم التليفون : 01223762473
العمر (تاريخ الميلاد) : 06-12-1977 المهنة : بدون عمل
العنوان : **
تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....) المقر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي
الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: سحر نبيل حسين الاعصر
National ID: 27712060102289



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وماعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وماعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



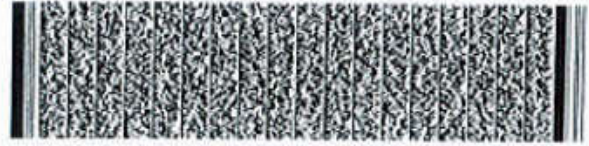
محرر
نبيل حسين الأعصر
٥١ من الممیزی
الزیتون - القاهرة

١٩٧٧/١٢/٢٩ ٢٧٧ ١٢ ٠٦ ٠١ ٠٢٢ ٨٩
I02164371

٢٠٢٠/٠٩ ٢٧٧ ١٢ ٠٦ ٠١ ٠٢٢ ٨٩

حاصلة على ليسانس أدب
برنامج الدراسات السياحية
أنثى
مستعدة
محمّد فاخر علی حسن عطل
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٩/١٥

١





رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2025-5-7

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة السعيه .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى
والبحت تبين ان



السيد (د) سحر نبيل حسين الاعصر بطاقة رقم 27712060102289

تليفون رقم: 01223223467

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
بغير من الفئات غير المستفحه بالتأمين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة
العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2025-5-7

الموظف المختص

ك. سمح محمود

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد...

مسئله 1645323



الخطاب ماري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاصدار الا فى حالة تغير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيه او
وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

MDT FORM 13 / 11 / 2025 G

Name	سحر نبيل حسين	MRN	150/2023
Age	47 yrs	ID	٢٧١٢٠١٠٢٢٩
Menopausal status	postmenopausal	Phone	٠١٥٠١٩٥٩٩
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	
CO morbidity	-ve	REASON OF MDT	DP

Clinical Data

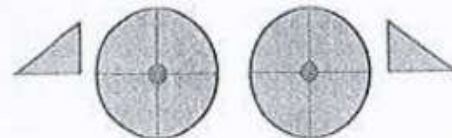
BX: IDC

R

(L)

ER: 818 PR: 818 HER 2: -ve Ki67:

Sonomammography:



Mets Workup:

New CT CAP (24/9/2025) - 4 cm of 11 sided TNM lung liver bone
Pleural effusion
No suspicious pulmonary masses
No progression of bony mets
P size and number of 11 Lobe HFL now 4.2 cm

Recommendations:

2016- 11 MPM upfront → 4AC+4TXT, PORT then TAM till 11/2022

(1-2023) PET scan - 11 pleural thick, mediastinal LN, Bone mets

11 pleural fluid → of Breast origin, ER, PR 818 16/2(-ve)

started (EBrance + Fasidex + Zometa) from (4/2023 to 1-2025), Relapsed Rth to 11 St. Duct

(1-2025) CT CAP → Newly developed HFL Bx of Breast origin (local)

MDT OUTCOME & PLAN The started Afinitor + Aramisine from (2-2025) to (10-2025)

Shift to CH "Xeloda" single agent @ 2.0 g/m² bid

q. 3.40 except if "major" adverse cases and

Signature

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
3/11/2025					

Patient Name : الأستاذة / سحر نبيل حسين الاعصر :	Request No. : 13004951
Patient No. : 27712060102289	Request Date : 17/01/2023
Path No. : SR-45/2023	Verification Date : 24/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 45 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data: Known case of left breast cancer with pulmonary nodule and pleural effusion.

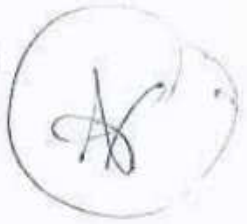
Specimen : Slide revision

Gross:

Two paraffin blocks labeled as (2718 and 254/22) and 18 slides were received.

Microscopic:

- Biopsy and cell block slides: show haemorrhagic fragments and cell block material with hyperplastic mesothelial cells. Few atypical cells showed positive staining for ER, PR, GATA3. Her2 is negative.
- Cytology smears show focally hypercellular smears of pleural effusion with sheets of atypical glandular epithelial cells, consistent with metastasis from clinically stated breast cancer.



Diagnosis:

- 1- Biopsy and cell block slides:
 - Haemorrhagic and hypocellular with hyperplastic mesothelial cells
- 2- Cytology smears slides:
 - Focally hypercellular with sheets of atypical cells consistent with metastatic carcinoma.
 - For correlation with clinical, radiological findings.

Signature :

Prof. Dr. Eman Gouda

Dr. Heba Mostafa

Verified by :

walaa ghoniem

د. أحمد كمال الدري
د. محمد أبو الهدى درويش
د. عمر حسين عمر
د. وحيده حسين طنطاوي
د. ياسر عبد العظيم عباس
د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

مركز مصر للأشعة
MISR RADIOLOGY
CENTER



MRS. SAHAR NABIL HUSSAIN EL AASAR
DEAR SIR

PATIENT ID: 818702
STUDY DATE: 20/05/2026

Status post left mastectomy, when compared to the previous study dated 04/02/2026, the current study reveals:

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE CHEST

Multislice axial contiguous thin cuts were taken through the chest after I.V. **non-ionic** contrast injection.

FINDINGS:-

- Clear left mastectomy operative bed with no sizeable masses.
- Stationary appearance of the heterogeneous, non-enhancing soft tissue lesion seen at the left thoracic outlet, encasing the major vessels with no vascular attenuation or thrombosis.
- No sizeable right breast or suspicious axillary lesions.
- Stationary appearance and amount of the left-sided pleural effusion with underlying collapse of the left lower lobe, showing mild pleural thickening, yet no sizeable pleural masses.
- Stationary appearance of the small inflammatory consolidation seen at the left upper lobe, which could be post-therapeutic.
- Multiple newly developed, tiny 3 - 4 mm ground-glass nodules showing central cavitation, the largest is seen at the right lower lobe base, mostly of chronic inflammatory nature.
- No right-sided pleural effusion or thickening.
- No significant mediastinal or hilar adenopathy.
- Patent tracheo bronchial tree.

IMPRESSION:-

- Stationary appearance and amount of the left-sided pleural effusion.
- Stationary appearance of the inflammatory zone seen at the left upper lobe.
- Stationary appearance of the enhancing zones seen related to the left thoracic outlet, mostly post-operative granulation tissue.
- Few newly developed ground-glass nodules showing central cavitation, mostly of chronic inflammatory nature, for follow-up.

أ.د. أحمد كمال الدري
أ.د. محمد أبو الهدى درويش
أ.د. عمر حسين عمر
أ.د. وحيد حسين طنطاوي
أ.د. ياسر عبد العظيم عباس
أ.د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. SAHAR NABIL HUSSAIN EL AASAR
DEAR SIR

PATIENT ID: 818702
STUDY DATE: 20/05/2026

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:-

Multislice post contrast CT scan of the abdomen and pelvis with multiplanar reformatted images revealed:-

FINDINGS:-

- The liver is mildly enlarged, showing further decrease in size and number of the hepatic focal lesions. The largest now measures 7 mm at segment VIII.
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.
- The portal vein is patent with no thrombosis.
- Normal CT appearance of the spleen and pancreas and both suprarenal glands.
- Both kidneys are functioning and normal.
- Normal filling of the urinary bladder with normal wall thickness and no calculi.
- IVC filter is seen in place.
- The uterus and ovaries show no solid or cystic masses.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Stationary appearance of the size and number of the widespread sclerotic bony lesions seen involving the spine, pelvic bones, as well as the malunited pathological fracture seen involving the left femur with few extra-osseous soft tissue components seen involving the left iliac bone, with wedging of the bodies of D3 and L4 vertebrae.

IMPRESSION:-

- Further decrease in size and number of the hepatic focal lesions.
- Stationary appearance of the widespread sclerotic bony lesions, for correlation with bone scan.

MUCH OBLIGED
PROF DR. AHMED FATHY
PROF.DR. YASSER IBRAHIM



عيادات المحبة التخصصية الخيرية
El Mahaba + Polyclinic

NAME	د. نيل حسين	DATE	5/2/2026
REFERRED BY		AGE	47
ACCECCION		SEX	F

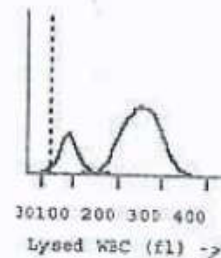
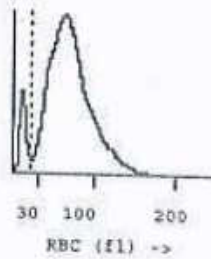
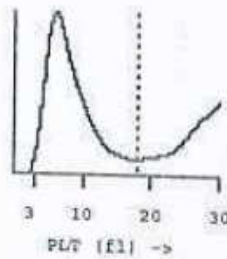
COMPLETE BLOOD PICTURE

ID = SAHR
SEQ = 9353
DATE = 05/02/2026
TIME = 22:27:02

FEMALE OT

Normal ranges

HGB = L 10.3	g/dl	11.5 : 16.5
RBC = 4.52	$10^{12}/l$	3.80 : 5.50
HCT = L 30.6	%	37.0 : 50.0
MCV = L 67.8	fl	76.0 : 96.0
MCH = L 22.8	pg	27.0 : 32.0
MCHC = 33.7	g/dl	31.0 : 35.0
RDW% = H 26.7	%	11.0 : 16.0
WBC = 7.0	$10^9/l$	4.0 : 11.0
LYM% = 20.9	%	20.0 : 40.0
LYM = 1.4	$10^9/l$	1.0 : 4.0
MID% = 5.5	%	2.0 : 10.0
MID = 0.4	$10^9/l$	0.2 : 1.0
GRA% = 73.6	%	40.0 : 75.0
GRAN = 5.2	$10^9/l$	2.0 : 7.0
PLT = H 442	$10^9/l$	150 : 400
MPV = 7.7	fl	7.4 : 11.0





عيادات المحبة التخصصية الخيرية
El Mahaba + Polyclinic

NAME	مسحر نبيل حمدين	DATE	5/2/2026
REFERRED BY		AGE	47
ACCECCION		SEX	F

	RESULT	REFERENCE RANGE
<u>LIVER EVALUATION</u>		
ALT (SGPT)	39	F 0 -32U/L M 0 - 42 U/L
AST (SGOT)	47	F 0 - 31 U/L M 0 - 37 U/L
TOTAL BILIRUBIN	0.84	0.3 - 1.0 mg/dl
DIRECT BILIRUBIN	0.17	0.0 0.3 mg/dl
<u>KIDNEY EVALUATION</u>		
UREA	37	17 - 43 mg/dl
CREATININE	0.93	F 0.6 - 1.1 mg/dl M 0.7 -1.4 mg/dl
URIC ACID	4.38	F 2.4 - 5.7mg/dl M 3.4-7mg/dl



عيادات المحبة التخصصية الخيرية
El Mahaba + Polyclinic

NAME	سحر نبيل حسين	DATE	5/2/2026
REFERRED BY		AGE	47
ACCESSION		SEX	F

	RESULT	REFERENCE RANGE
CALCIUM	9.9	8.5 - 10.5 mg/dl
ADULT		10 - 12mg/dl
< 2 YEARS		
IONIZED CALCIUM	4.55	4 - 4.8mg/dl



د. أحمد كمال البحري
د. محمد أبو الهدي حريش
د. عمر حسين عامر
د. وصيد حسين طنطاوي
د. ياسر عيد العظيمة عباس
د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. SAHAR NABIL HUSSAIN EL ASAR
DEAR SIR

PATIENT ID: 818702
STUDY DATE: 04/02/2026

Status post left mastectomy, when compared to the previous CT dated 24/9/2025, the current study revealed:

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE CHEST

Multislice axial contiguous thin cuts were taken through the chest after I.V. non-ionic contrast injection.

FINDINGS:-

- Stationary appearance in amount of the left sided pleural effusion with underlying collapse of the left lower lobe.
- Stationary appearance of the mild pleural thickening, yet no sizable pleural masses or nodules.
- Stationary appearance of the small inflammatory consolidation seen at the apical posterior segment of the left upper lobe that could be post therapeutic changes.
- Complete resolution of the previously noted inflammatory consolidation seen at the right lower lobe lateral segment.
- No suspicious pulmonary masses or nodules.
- Stationary appearance of the faintly enhancing soft tissue seen at the left thoracic outlet encasing the major vessels with no vascular invasion or thrombosis.
- Stationary appearance of the few reactive mediastinal lymph nodes.
- The mastectomy operative bed as well as the right breast and axilla show no sizable enhancing masses.
- No right pleural effusion.
- Patent airway.

IMPRESSION:-

- Stationary appearance in amount of the left sided pleural effusion and left lower lobe collapse.
- Stationary appearance of the inflammatory zone seen at the left upper lobe, could be post therapeutic.
- Complete resolution of the right lower lobe inflammatory zone.
- Stationary appearance of the enhancing zone seen at the left thoracic outlet, mostly postoperative granulation tissue.
- No newly developed suspicious lesions.

د. أحمد كمال السحري
د. محمد أبو الهدى درويش
د. عمر حسين عبد
د. وحيد حسين طنطاوي
د. ياسر عبد العظيم عباس
د. أحمد محمد مانيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. SAHAR NABIL HUSSAIN EL ASAR
DEAR SIR

PATIENT ID: 818702
STUDY DATE: 04/02/2026

MULTISLICE TRIPHASIC C.T. SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:-

Multislice post contrast CT scan of the abdomen and pelvis with multiplanar reformatted images revealed:-

FINDINGS:-

- The liver is of average size with homogenous CT density showing decrease in size and number of the hepatic focal lesions, the largest now measures 15mm at segment III, (compared to 42mm previously).
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.
- The portal vein is patent with no thrombosis.
- Normal CT appearance of the spleen and pancreas and both suprarenal glands.
- Both kidneys are functioning and normal.
- Normal filling of the urinary bladder with normal wall thickness and no calculi.
- Both ovaries show no solid or cystic masses.
- No suspicious paraaortic lymph nodes.
- Stationary appearance of the left pararenal reactive lymph nodes, the largest is 8mm.
- IVC filter is seen in place.
- No ascites.
- Stationary appearance in size and number of the widespread sclerotic bony lesion seen involving the spine and pelvic bones with zones of rarefaction and extraosseous soft tissue component, seen at the left iliac bone, as well as the wedging of the bodies of D3 and L4 vertebra.
- Stationary appearance of the pathological malunited fracture seen involving the left femur with associated angulation and deformity.

د. أحمد جمال الدين
د. محمد أبو الهدي جويش
د. عمر حسين عيسى
د. وديع حسين طنطاوي
د. ياسر عبد العظيم عباس
د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. SAHAR NABIL HUSSAIN EL ASAR
DEAR SIR

PATIENT ID: 818702
STUDY DATE: 04/02/2026

IMPRESSION:-

- Decrease in size and number of the hepatic metastatic deposits.
- Rather stationary course of the bony widespread metastatic deposits as well as the left femoral pathological fracture.

MUCH OBLIGED
PROF DR. AHMED FATHY
PROF.DR. YASSER IBRAHIM
AIA



PATHOLOGY REPORT

Code:	24825501298 -(TM 339-25)	Patient Name:	سحر نبيل حسين
Age:	47 Y	Sex:	Female
Branch:	Sheraton	Specimen Received Date:	23/01/2025
Referred By Prof:	هشام النوكيل	Date Report Issued:	28/01/2025
		Unit Manager:	Prof. Dr. Ahmed Abdelaziz

CLINICAL DATA: A case of hepatic focal lesion, mostly metastatic breast cancer, for histopathological examination, estrogen, progesterone receptors & Her-2/neu.

MICROSCOPIC PICTURE: Serial sections examined revealed the picture of metastatic carcinoma.

PROCEDURE: Sections from paraffin block were treated with antigen retrieval solution and then treated with monoclonal antibodies for estrogen, progesterone receptors, & Her-2/neu, (CONFIRM™ anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit & CONFIRM™ anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2) & CONFIRM™ anti-HER-2/neu (4B5) Primary Antibody), using Ventana UltraView Universal DAB Detection Kit, with Hematoxylin II as a counter stain.

RESULTS:

Examination of section treated for estrogen receptors revealed weak positive nuclear staining of 80% tumor cells by chromogen.

Examination of section treated for progesterone receptors revealed weak positive nuclear staining of 10% tumor cells by chromogen.

Examination of section treated for Her-2/neu revealed incomplete faint/barely perceptible cytoplasmic membrane staining of >10% tumor cells by chromogen (score 1+).

CONCLUSION: Metastatic Breast Duct Carcinoma.

Tumor Cells Are:

- **Positive** For Estrogen Receptors.
- **Positive** For Progesterone Receptors.
- **Her-2 Low** (Score 1+).

COMMENT: All controls show appropriate reactivity.

*4 slides enclosed.

Ahmed

Prof. Dr. Ahmed Abd El Aziz, M.D.
Professor Of Pathology
Faculty Of Medicine, Cairo University

NOTE: This report was generated by computer, any manual correction will make it null and void.

Dr. Ahmed El-Habashi, MD, PhD, FIAC
Professor of Pathology;
NCI, Cairo University
International Board of Cytopathology
Fellow of International Academy of Cytology
Member of American Society Of Cytology
Fellow, Tulane Univ. Hospital, USA
Fellow, Groningen Univ. Hospital, Holland

أ.د. أحمد حسين الحبشي
استاذ الباثولوجي - المعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة
بورء السيٲولوجي الدولي
زميل الاكاديمية الدولية للسيٲولوجي
عضو الجمعية الأمريكية للسيٲولوجي
زميل جامعة تولين - نيو اورليانز - امريكا
زميل جامعة خرونينجن - هولندا

Patient Name: مسحر نبييل حسين

Age: 44 Y-O

Gender: Female

Clinical History: BAL, Adenocarcinoma

Nature of Specimen: BAL, Cell block, ER/PR, and Her-2immunostainings.

Referring Prof. Doctor: Hisham Al-Wakeel

Date of Specimen Receiving: 1/1/2023

Date of Reporting: 3/1/2023

Immunohistochemistry Report

Gross Description:

Cell block sections were immunostained for estrogen and progesterone receptors as well as Her-2 using ABC technique and DAB chromogen.

Microscopic Description:

Tumor cells showed strong positive immunoreactivity for estrogen (3+) and progesterone (3+) receptors. No tumor cells showed immunostainings for Her-2 (neu) receptor

Her2 scoring system and criteria

0 Negative: No staining is observed, or membrane staining is <10% of the tumor cells.

1+ Negative: A faint /barely perceptible membrane staining is detected in >10% of the tumor cells. The cells are only stained in part of the membrane.

2+ Weak positive: A weak to moderate complete membrane staining is observed in >10% of the tumor cells.

3+ Positive: A strong complete membrane staining is observed in >10% of the tumor cells.

Diagnosis:

BAL, Cell Block, ER/PR, KI-67& Her-2/neu Immunostainings:

Estrogen Receptor: Positive (3+, score 8/8).

Progesterone Receptor: Positive (3+, score 8/8).

Her-2 (neu) Receptor: Negative (0).

GATA3: Positive (Mammary carcinoma)

Comment: score 0 & 1 of Her-2 are negative, Score 2 positive needs confirmation by FISH or CISH while score 3 is positive.

Ahmed El-Habashi, MD, FIAC

١٠ شارع صبرى أبو علم بجوار وزارة الاوقاف - باب اللوق - القاهرة

تليفون : ٢٣٩٢٩٩٣٧ موبائل : ٠١٦٦٧٣٦٦٠٨

E-Mail: elhabashiahmed@yahoo.com